3.临床表现

①**黄疸**：出现早、**进行性加重**肿瘤越长越大（胆汁排不出来）

②**中下段**胆管癌触及**无痛、光滑、肿大的胆囊（courvoisier 征）**；而**上段**胆管癌**胆囊无肿大甚至可缩小**

③胆管癌生长缓慢，主要是淋巴转移、局部浸润、腹腔种植 远处转移相对要少

④**超声内镜**判断胆管癌浸润深度、穿刺活检 属于内镜(带有超声探头)

VS病理学肿瘤总论-恶性肿瘤但生长缓慢:①皮肤的基底细胞癌②卵巢的粒层细胞瘤

4.治疗

（1）根治性手术切除+清除肝十二指肠韧带内所有淋巴结（脉络化）（记）

①**下段**胆管癌：**胰头十二指肠切除术 Whipple 术**（含切胆囊）、或联合切除肝（肿瘤累及肝）

②中段胆管癌：切肿瘤及距肿瘤边缘 1cm 的胆管（一旦中了）、作肝管-空肠 RY 吻合（保证切缘阴性）

③**上段/肝门部**胆管癌：

临床上胆肠吻合是一个很大的概念,这个"胆"有可能指的是胆管,也有可能指的是肝管,+切胆囊(胆汁直接流到肠道,无Oddi括约肌)

I肿瘤在**肝总管**	**切胆囊**+肝外胆管、作胆肠 RY 吻合
II肿瘤侵犯左右肝管**汇合部**	（癌位置高）
III侵犯**右肝管IIIa 或左肝管IIIb**（a 的一竖在右边、b 在左边）	**切胆囊**+肝外胆管+部分肝、作胆肠 RY 吻合
IV同时侵犯右、左肝管	多姑息治疗

只要做胆肠吻合就要切胆囊(无Oddi括约肌)

①食管癌:切肿块及其上下缘≥5-8cm的组织（五八同城买食材）

②胃癌:一般5cm,位于两端的癌切除食管下端或十二指肠1部的3-4cm（无端生事）

③保乳乳腺癌切除术适合I、II期(切肿块+1-2cm组织)

④直肠癌:一般来说Dixon术,切缘≥2cm,低位Dixon术,切缘≥1cm

⑤结肠癌:肿瘤远端距切缘≥10cm（师姐）

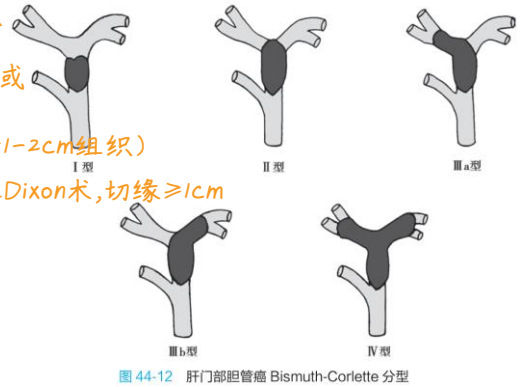


图 44-12 肝门部胆管癌 Bismuth-Corlette 分型

（2）姑息性治疗 减黄 VS胰头癌失去手术机会时,通过做引流来减黄,如PTCD、ENBD,放置内支架

①胆道引流术：PTCD、ENBD、放置内支架。若术中发现肿瘤不能切除作肝肠吻合或胆肠吻合内引流术

②胃空肠吻合术：肿瘤侵犯或压迫十二指肠造成消化道梗阻（绕开十二指肠）

（3）吉西他滨等化疗 同胰头癌(CA199)

八、胆管出血

①肝内胆管出血多见

②原因：感染、创伤、肿瘤、血管性胆管出血，以胆管结石感染最常见（Charcot 三联征+上消化道出血）

③治疗：多保守治疗（出血量不大）。手术指征有反复发作大出血、合并严重胆管感染需手术引流者、引流术后发生胆管大出血者、原发疾病需要外科手术治疗者

九、胆管蛔虫

①**阵发性钻顶样绞痛，突发突止**（间歇期可完全缓解无症状），剧烈腹痛与较轻腹部体征不相称（虫子要休息）（VS阵发性室上速）

②多无黄疸或轻度黄疸（多为不完全性梗阻）

③多保守治疗

症征不符:
①肠系膜上动脉栓塞
②十二指肠2,3部损伤